

Série de questions Asthme de l'enfant et du nourrisson Résidanat 2025

Q1 : L'asthme chez le nourrisson se définit par :

- A) Une dyspnée sifflante avec une distension à la radiographie de thorax
- B) Une dyspnée sifflante continue depuis la naissance
- C) Toux persistante après une virose
- D) Une toux induite par l'effort
- E) Le caractère constant du sifflement

Q2 : Concernant les caractéristiques de l'asthme chez l'enfant, quelles affirmations sont justes? :

- A) Une variabilité en intensité des symptômes respiratoires
- B) Le diagnostic n'est confirmée qu'après une EFR
- C) L'absence d'hypersensibilité exclut le diagnostic
- D) Il existe une limitation variable des débits expiratoires
- E) Une exacerbation peut inaugurer la maladie

Q3 : Les éléments cliniques suivants sont suggestifs de diagnostic de l'asthme chez l'adolescent :

- A) Accentuation des symptômes respiratoires en fin de journée
- B) Une sensation d'oppression thoracique
- C) La disparition des symptômes aigus sous corticoïdes inhalés
- D) Les émotions peuvent déclencher des symptômes aigus
- E) L'infection virale aggrave les symptômes pré existants

Q4 : Ces propositions concernant le diagnostic positif de l'asthme sont vraies :

- A) L'absence de râles sibilants à l'auscultation pulmonaire exclut le diagnostic
- B) L'association de plusieurs symptômes respiratoires remet en doute le diagnostic d'asthme
- C) L'anomalie radiologique typique est la distension thoracique
- D) Un syndrome obstructif à la spirométrie confirme le diagnostic chez l'enfant d'âge préscolaire
- E) La positivité des prick test confirme le diagnostic de l'asthme

Q5 : Concernant l'exploration fonctionnelle respiratoire chez l'enfant au cours de l'asthme :

- A) Le seuil de définition du syndrome obstructif est un rapport VEMS/CVF < 0.7
- B) Le test de réversibilité se fait avec la métacholine
- C) Se pratique avec la mesure des résistances spécifiques chez l'enfant de < 6 ans
- D) La courbe débit volume a une valeur diagnostique
- E) Un syndrome restrictif témoigne d'un asthme léger

Q6 : L'association de ces éléments cliniques fait évoquer le diagnostic de l'asthme chez le grand enfant :

- A) Une mère suivie pour une rhinite allergique
- B) Une exposition permanente au tabac
- C) Une hypersensibilité aux acariens
- D) La présence d'une obésité
- E) Le déclenchement de symptômes l'occasion d'une virose

Q7 : Ces affirmations concernant le diagnostic étiologique de l'asthme sont vraies :

- A) Une allergie aux acariens est attestée par une papule $< 50\%$ du diamètre du témoin positif au Prick test
- B) La prise d'un anti histaminique fausse les tests cutanés
- C) Un taux des IgE totaux normal élimine l'origine allergique
- D) Un RGO est à la fois une cause et conséquence de l'asthme
- E) L'asthme viro-induit est souvent de bon pronostic

Q8 : Vous recevez aux urgences un enfant de 4 ans asthmatique qui présente une exacerbation, quels sont parmi ces signes cliniques ceux qui cadrent avec une crise sévère :

- A) Une tachycardie à 120 bpm
- B) Une $SpO_2 \leq 92\%$
- C) L'utilisation des muscles respiratoires accessoires
- D) Les troubles de l'élocution
- E) L'absence d'amélioration après deux bouffées de BDCA

Q9 : L'asthme aigu grave chez l'enfant est favorisé par :

- A) Un antécédent de ventilation mécanique au cours d'une crise d'asthme
- B) Des exacerbations fréquentes d'asthme
- C) Un traitement de fond qui ne comporte pas de corticoïdes inhalés
- D) Une allergie aux acariens
- E) Un arrêt temporaire durant l'été du traitement de fond

Q10 : La présence des signes radiologiques suivants est contre le diagnostic de l'asthme :

- A) Des bases pulmonaires emphysémateuses en bilatéral
- B) La présence d'un situs inversus
- C) Une dilatation des bronches bilatérales
- D) Une hyperclarté des champs pulmonaires
- E) Un aspect de coeur en goutte

Q11 : Farah, âgée de 8 ans, s'est présentée aux urgences pour une crise d'asthme sévère, relevez parmi ces éléments ceux prédicteurs d'un asthme aigu grave :

- A) Une polypnée à 25 c/min
- B) Un pic hypertensif
- C) La présence de signes de pré épuisement respiratoire
- D) La présence d'un tirage sus sternal
- E) La présence d'un silence à l'auscultation pulmonaire

Q12 : Ces éléments cliniques font redouter un diagnostic différentiel de l'asthme chez l'enfant :

- A) Une toux grasse matinale
- B) Une otite à répétition
- C) Un retard de croissance sévère
- D) Une exacerbation des symptômes respiratoires aux efforts
- E) La présence d'une allergie aux protéines de lait de vache associée

Q13 : L'évaluation globale du contrôle de l'asthme chez l'enfant fait intervenir :

- A) Évaluation du risque d'exacerbation
- B) Évaluation du degré d'adhésion thérapeutique
- C) Une EFR deux fois /an, tous les ans
- D) Répétition de l'enquête allergologique
- E) La pratique d'une radiographie de thorax une fois/an

Q14 : L'obstruction fixée dans l'asthme est favorisée par :

- A) Un asthme de phénotype allergique
- B) Une exposition permanente au tabac
- C) Un antécédent de faible poids de naissance
- D) Une utilisation fréquente de BDCA
- E) Une utilisation de fortes doses de corticoïdes inhalés

Q15 : Le traitement de fond de l'asthme chez l'enfant:

- A) Inclut une corticothérapie orale et inhalée
- B) Associe les BDLA chez le grand enfant
- C) La corticothérapie est ajustée a la plus faible dose efficace
- D) Est administré via une chambre d'inhalation + masque chez le grand enfant
- E) Le palier est a changer en cas de nouvelle exacerbation

Q16 : Le traitement de fond chez un enfant âgé de moins de 5 ans :

- A) Associe une faible dose de corticoide inhalé aux BDLA très faible dose au palier 3
- B) Comporte une corticothérapie inhalée intermittente
- C) Doit faire éviter les fortes doses de corticoïdes inhalés
- D) Est administré a travers des inhalateurs de poudre
- E) Se base sur une immunothérapie si allergie documentée

Q17 : Le traitement de l'exacerbation de l'asthme inclut :

- A) L'utilisation en urgence des BDCA par voie inhalée
- B) Le recours au sulfate de magnésium si crise modérée
- C) L'utilisation de corticoïdes en IV en cas de crise modérée
- D) Le recours aux anti-leucotriènes si crise légère a modérée
- E) Le recours aux bromures d'ipratropium si crise légère

Q18 Les facteurs associés au mauvais pronostic au cours de l'asthme chez l'enfant sont :

- A) L'utilisation de moins de 1 flacon / mois de bronchodilatateur rapide
- B) Des symptômes d'asthme non contrôlés
- C) Une allergie alimentaire associée
- D) Un antécédent d'exacerbation modérée l'an précédent
- E) L'association a une rhinosinusite

Cas clinique :

Youssef est une enfant âgée de 10 ans . Il est suivi pour un asthme depuis l'âge de 6 ans, le diagnostic était retenu devant deux crises d'asthme à l'âge de 6 ans. Il reçoit un traitement à base de fluticasone inhalée faible dose + un antileucotriène avec des BDCA à la demande. Il présente des symptômes diurnes une fois /mois, un réveil nocturne plus que deux fois /semaine. Sa maman rapporte qu'il est gêné à la séance d'éducation sportive un flacon de BDCA/mois sans chambre d'inhalation. Il vous consulte aux urgences pour une dyspnée fébrile. A l'examen , T° 38.2 , poids = 60 Kg, il présente une crise d'asthme modérée.

1) Quels sont les éléments en faveur d'un asthme mal contrôlé chez cet enfant

- A) La présence de symptômes diurnes
- B) La présence de symptômes nocturnes
- C) L'utilisation fréquente de BDCA
- D) L'ancienneté de l'asthme
- E) La bithérapie au traitement de fond

2) Quels sont les facteurs de risque d'évolution défavorable chez cet enfant ? :

- A) Une consommation excessive de bronchodilatateur
- B) Le terrain d'obésité
- C) La mauvaise technique d'administration de traitement
- D) Les doses faibles de corticostéroïdes inhalés
- E) La nécessité d'un anti leucotriène

Q3 : Que proposeriez vous pour la prise en charge à moyen terme de Youssef ?

- A) Des prick tests
- B) Programmer une EFR dans les jours suivants
- C) Révision de l'observance thérapeutique
- D) Augmentation du palier de traitement
- E) Proscrire l'activité sportive